Estilo UERJ

Simulado R02 Caderno

Simulado de revisão no formato da UERJ, montado a partir dos seus erros nos Simulados 1 a 4: quatro alternativas e a armadilha da banca em cada questão.

50 questões

26 de outubro de 2026

ANTES DE COMEÇAR

Instruções

- São 50 questões de Clínica Médica, com quatro alternativas cada (A a D) e uma única correta.
- Tempo sugerido: 2 horas e 30 minutos, sem consulta, de uma vez só.
- Marque as respostas na folha de respostas da última página, e só depois abra a resolução.
- Nas questões de identificar, faça o teste do resto: liste os achados e veja se a hipótese explica todos. Antes de pedir exame ou tratamento, pergunte qual é o degrau mais simples que resolve e o que o paciente já usa.
- Na correção, anote em qual arma da banca você caiu. É isso que vai para o diagnóstico, não o total.

1 Mulher de 58 anos, com prótese mecânica mitral implantada há 5 meses, em uso de varfarina, fez colonoscopia com polipectomia há 3 semanas e há 10 dias tem febre de 38,4 °C diária, sudorese noturna e astenia. Ao exame, PA 118 × 70 mmHg, FC 98 bpm, clique metálico nítido, sopro sistólico novo em foco mitral grau 2+/6+, sem sinais de insuficiência cardíaca. Ferida operatória cicatrizada. Ecocardiograma transesofágico: vegetação de 8 mm no anel protético com pequeno leak paravalvar, sem abscesso. Três pares de hemoculturas foram colhidos há 1 hora, ainda sem resultado. INR 2,8, creatinina 0,9 mg/dL. Enquanto aguarda as culturas, o esquema empírico mais adequado é:

A) Ampicilina com ceftriaxona

B) Penicilina cristalina com gentamicina

C) Oxacilina com gentamicina

D) Vancomicina, gentamicina e rifampicina

---

2 Mulher de 58 anos, assintomática, sem febre, sudorese ou perda de peso, notou linfonodos cervicais e axilares há 8 meses. TC: linfonodomegalias cervicais, axilares, mediastinais e retroperitoneais, todas abaixo de 3 cm (a maior com 2,9 cm), baço de 12 cm e derrame pleural direito moderado, cuja citologia mostra linfócitos B pequenos clonais. Hemoglobina 12,8 g/dL, leucócitos 6.900/mm³, plaquetas 188.000/mm³, LDH 210 U/L (até 250). Biópsia excisional axilar: padrão nodular, CD20+, CD10+, BCL2+, BCL6+, CD5 negativo, ciclina D1 negativa, grau 1 a 2. O diagnóstico e a conduta mais adequados são, respectivamente:

A) Linfoma do manto / ibrutinibe

B) Linfoma folicular / observação vigilante

C) Linfoma de zona marginal / rituximabe isolado

D) Linfoma folicular / imunoquimioterapia com anti-CD20

---

3 Homem de 79 anos, com condrocalcinose dos joelhos documentada há 5 anos e duas crises prévias de pseudogota, está internado há 9 dias por pneumonia, já em melhora. Há 4 dias surgiu flebite no local do cateter venoso periférico, retirado; hoje tem febre de 38,4 °C e joelho direito quente, edemaciado e doloroso, com derrame volumoso. Artrocentese: líquido turvo, 62.000 leucócitos/mm³ com 91% de neutrófilos, cristais romboides com birrefringência positiva fraca, bacterioscopia pelo Gram sem bactérias. Radiografia: condrocalcinose sem erosões. Hemoculturas colhidas, em processamento. A conduta mais adequada é:

A) Colchicina oral em dose baixa

B) Triancinolona intra-articular

C) Prednisona oral 30 mg/dia

D) Drenagem e antibiótico venoso

---

4 Homem de 74 anos, com diabetes tipo 2 e demência leve, chega com 5 dias de poliúria, sede e confusão progressiva. Na admissão, PA 88 × 50 mmHg e FC 122 bpm; recebeu 2.000 mL de solução salina a 0,9% em 2 horas. Agora, PA 126 × 74 mmHg, FC 96 bpm, diurese de 60 mL/h, sem sinais de congestão. Glicemia 880 mg/dL, sódio medido de 148 mEq/L, potássio 4,4 mEq/L, osmolalidade efetiva 345 mOsm/kg, pH 7,34, bicarbonato 21 mEq/L, cetonemia negativa, creatinina 2,0 mg/dL. A solução venosa e a insulina mais adequadas neste momento são, respectivamente:

A) Salina a 0,9% / insulina contínua

B) Salina a 0,9% / insulina só abaixo de 300

C) Glicosado a 5% / insulina contínua

D) Salina a 0,45% / insulina contínua

---

5 Homem de 61 anos, com cirrose por hepatite C tratada com resposta virológica sustentada há 3 anos, é internado pelo terceiro episódio de encefalopatia hepática grau 2 em 8 meses. Usa lactulose com 2 a 3 evacuações pastosas ao dia, confirmadas pela esposa, e rifaximina há 5 meses. Em todas as internações não se achou infecção, sangramento, distúrbio eletrolítico, uso de sedativo, constipação ou hipoglicemia. Child-Pugh A6, MELD 9, sem ascite. Ultrassonografia com Doppler: fígado de contornos irregulares, baço de 15 cm, veia porta pérvia de calibre reduzido. TSH e B12 normais. O próximo exame mais adequado é:

A) Ressonância de crânio com espectroscopia

B) Eletroencefalograma

C) Angiotomografia do abdome

D) Amônia sérica arterial

---

6 Homem de 46 anos fez manipulação cervical com quiroprático há 2 dias e desde então tem dor na nuca à direita. Há 6 horas teve vertigem súbita, vômitos, rouquidão, dificuldade para engolir a própria saliva e soluços incessantes. Exame: alerta, PA 152 × 90 mmHg; ptose e miose à direita, nistagmo horizontal, palato que se eleva menos à direita com reflexo nauseoso diminuído desse lado, ataxia dos membros à direita, força preservada nos quatro membros, língua na linha média e reflexos simétricos, sem sinal de Babinski. Ainda não foi testada a sensibilidade. O achado sensitivo mais provável é:

A) Hipoalgesia na hemiface e no hemicorpo direitos

B) Hipoalgesia na hemiface esquerda e no hemicorpo direito

C) Hipoalgesia na hemiface direita e no hemicorpo esquerdo

D) Perda proprioceptiva no hemicorpo esquerdo

---

7 Mulher de 24 anos procura atendimento por cansaço aos esforços e palpitações há 1 ano. Desde o nascimento tem o polegar direito com três falanges, alinhado aos demais dedos, e hipoplasia do rádio direito; a mãe tem alteração semelhante na mão e 'um sopro no coração'. O irmão mais novo tem síndrome de Down e foi operado na infância de defeito do septo atrioventricular. Ao exame: PA 112 x 70 mmHg, FC 88 bpm, impulsão sistólica paraesternal esquerda, sopro sistólico ejetivo 2+/6 no foco pulmonar e desdobramento amplo de B2 que não varia com a respiração. Ecocardiograma solicitado, ainda não realizado. O achado eletrocardiográfico mais provável é:

A) Sobrecarga ventricular esquerda com strain

B) PR curto com onda delta

C) BRD incompleto com eixo desviado à direita

D) BRD incompleto com eixo desviado à esquerda

---

8 Mulher de 68 anos, com transtorno bipolar estável há 10 anos em uso de carbonato de lítio 900 mg/dia (última litemia de 0,8 mEq/L há 6 meses), é trazida pela filha por tremor grosseiro das mãos, marcha atáxica, fala arrastada e confusão progressivos há 5 dias. Há 3 semanas a clínica trocou a anlodipina por losartana e hidroclorotiazida 25 mg iniciada há 3 semanas no mesmo comprimido. PA 134/80 mmHg, FC 62 bpm, afebril, sem rigidez de nuca, sem déficit motor focal; mioclonias multifocais. Sódio 134 mEq/L, creatinina 1,3 mg/dL (basal 1,0), glicemia 110 mg/dL, cálcio 9,8 mg/dL. O exame mais adequado neste momento é:

A) Ressonância magnética de crânio

B) Eletroencefalograma

C) Litemia sérica

D) Punção lombar

---

9 Mulher de 58 anos, ex-usuária de drogas injetáveis, tem há 8 meses dor nas pequenas articulações das mãos e nos joelhos, sem edema articular, além de manchas avermelhadas e elevadas nas pernas, que surgem em surtos e deixam pigmentação ocre, e formigamento nos pés. Ao exame, púrpura palpável nos membros inferiores, sem sinovite, hipoestesia em bota. Fator reumatoide 380 UI/mL, anti-CCP negativo, C3 92 mg/dL (90 a 180), C4 de 3 mg/dL (VR 10 a 40), ANCA negativo, ALT 1,5 vez o limite superior. Creatinina 1,3 mg/dL, hematúria dismórfica e proteinúria de 0,9 g/24h. Radiografia de mãos sem erosões. O diagnóstico mais provável é:

A) Artrite reumatoide com vasculite

B) Vasculite crioglobulinêmica

C) Poliangeíte microscópica

D) Vasculite por IgA

---

10 Mulher de 52 anos, assintomática, comparece à consulta de rotina. Fez histerectomia total abdominal há 2 anos por miomatose uterina com sangramento, e o histopatológico do útero mostrou leiomiomas, com colo uterino sem neoplasia intraepitelial. Há 9 anos foi submetida a conização por lesão intraepitelial escamosa de alto grau (NIC 3), com margens livres, e teve dois controles citológicos normais depois disso. Vida sexual ativa, parceiro fixo. Nunca fumou. Quanto ao rastreamento do câncer do colo do útero, a conduta mais adequada é:

A) Encerrar o rastreamento

B) Manter rastreamento da cúpula vaginal

C) Colposcopia anual da cúpula

D) Rastrear só se houver sangramento

---

11 Homem de 44 anos, em indução para leucemia mieloide aguda, está internado com neutrófilos de 60/mm³ há 12 dias, em profilaxia com posaconazol. Iniciou febre há 5 dias e recebe cefepima desde então; a febre persiste, com picos de 38,9 °C, sem hipotensão. Há 1 dia tem tosse seca discreta, sem dispneia; SpO2 96% em ar ambiente, ausculta pulmonar sem alterações. Mucosite oral leve, cateter sem sinais flogísticos, abdome indolor. Hemoculturas seriadas negativas, urocultura negativa. Radiografia de tórax sem alterações. Galactomanana sérica de ontem: índice 0,2 (negativa). Creatinina 0,8 mg/dL. O próximo exame mais adequado é:

A) Ecocardiograma transesofágico

B) TC de tórax

C) Repetir a galactomanana sérica

D) Ultrassonografia de abdome

---

12 Mulher de 54 anos, com hiperparatireoidismo primário grave (cálcio 12,8 mg/dL, PTH 1.480 pg/mL, fosfatase alcalina 1.120 U/L) e lesões líticas nos ossos longos compatíveis com tumores marrons, foi submetida à retirada de adenoma de paratireoide de 4 g, com as demais glândulas normais. No terceiro dia de pós-operatório, refere parestesias periorais e nas mãos, com sinal de Chvostek presente. Cálcio total 7,1 mg/dL (albumina 3,9 g/dL), fósforo 1,8 mg/dL (2,5 a 4,5), magnésio 1,5 mg/dL (1,7 a 2,4), PTH 58 pg/mL (15 a 65), creatinina 0,8 mg/dL. O diagnóstico e a conduta mais adequados são, respectivamente:

A) Hipoparatireoidismo / calcitriol isolado

B) Hipomagnesemia / sulfato de magnésio isolado

C) Fome óssea / cálcio venoso e calcitriol

D) Fome óssea / fosfato venoso e cálcio

---

13 Homem de 49 anos, etilista, cujo irmão, com quem mora, termina tratamento para tuberculose pulmonar, procura atendimento por febre de 38,7 °C, tosse com expectoração amarelada e dor pleurítica à direita há 9 dias. Fez amoxicilina por 5 dias, sem melhora. Ao exame, FR 24 irpm, SpO2 93%, macicez e murmúrio abolido no terço inferior do hemitórax direito. Leucócitos 19.400/mm³. Radiografia: consolidação em base direita com derrame moderado. Toracocentese: líquido turvo, não purulento, pH 6,95, glicose 14 mg/dL (glicemia 112 mg/dL), LDH 2.900 U/L, proteína 4,6 g/dL, 12.800 células/mm³ com neutrófilos 88%, ADA 92 U/L; Gram sem bactérias. O diagnóstico mais provável é:

A) Tuberculose pleural

B) Derrame parapneumônico complicado

C) Derrame pleural reumatoide

D) Derrame parapneumônico não complicado

---

14 Homem de 39 anos, vivendo com HIV, sem tratamento antirretroviral, CD4 de 42 células/mm³, chega com tosse seca e dispneia progressiva há 3 semanas. Teve síndrome de Stevens-Johnson por sulfametoxazol-trimetoprima há 2 anos. FR 30 irpm, SpO2 86% em ar ambiente, PaO2 de 56 mmHg. TC com vidro fosco difuso bilateral; PCR para Pneumocystis jirovecii positiva no escarro induzido. Em internação anterior, atividade de G6PD de 8% do normal, dosada fora de crise hemolítica. Creatinina 0,9 mg/dL, glicemia 98 mg/dL, ECG com QTc de 430 ms. Prednisona já foi iniciada. O tratamento antimicrobiano mais adequado é:

A) Atovaquona oral

B) Dapsona com trimetoprima

C) Pentamidina intravenosa

D) Primaquina com clindamicina

---

15 Mulher de 74 anos tem marca-passo unicameral ventricular, programado em VVI a 60 bpm, implantado há 2 anos por bloqueio atrioventricular total, com eletrodo de fixação ativa e gerador no peitoral esquerdo. Há 1 mês tem tonturas e duas pré-síncopes, ambas enquanto carregava sacolas de compras ou varria a casa. Usa hidroclorotiazida e losartana, que o clínico suspeita estarem causando hipotensão postural. Holter: fora dos episódios, ritmo de marca-passo a 60 bpm, cada espícula seguida de QRS largo. Durante os sintomas, pausas de até 3,4 s sem nenhuma espícula, coincidindo com artefato de alta frequência na linha de base; não há espículas soltas sem QRS. Telemetria: bateria com tempo estimado de 7 anos e impedância do eletrodo estável. O diagnóstico mais provável é:

A) Sensibilidade excessiva (oversensing)

B) Falha de sensibilidade (undersensing)

C) Falha de captura ventricular

D) Esgotamento da bateria

---

16 Homem de 69 anos, tabagista de 50 maços-ano, procura atendimento por disfagia para sólidos e líquidos com regurgitação noturna e perda de 10 kg em 4 meses. Nega pirose prévia. Ao exame, emagrecido, sem linfonodomegalias palpáveis, abdome sem massas. Esofagografia: esôfago dilatado com afilamento distal em bico de pássaro. Manometria de alta resolução: relaxamento incompleto da junção esofagogástrica com aperistalse sem pressurização, padrão de acalasia tipo I. Endoscopia: mucosa sem lesões, com resistência firme à passagem do aparelho pela cárdia, que só cede com pressão. A hipótese principal e o próximo passo são, respectivamente:

A) Pseudoacalasia / ecoendoscopia e TC

B) Acalasia idiopática / miotomia endoscópica

C) Acalasia idiopática / dilatação pneumática

D) Esofagite eosinofílica / biópsias seriadas

---

17 Mulher de 49 anos está no 7º dia de hemorragia subaracnóidea por aneurisma da artéria comunicante anterior, embolizado no 1º dia, com sangue espesso nas cisternas e nos ventrículos laterais à TC inicial. Usa nimodipina 60 mg de 4/4 horas e está euvolêmica. Hoje, às 10 horas, ficou sonolenta e passou a ter dificuldade para encontrar palavras e fraqueza no braço e na face à direita. Afebril, PA 138 × 82 mmHg. Sódio 129 mEq/L (132 mEq/L na véspera), glicemia 118 mg/dL. TC de crânio: sem novo sangramento, ventrículos com as mesmas dimensões da TC de 2 dias antes. Doppler transcraniano: velocidade média de 210 cm/s na artéria cerebral média esquerda, índice de Lindegaard de 5,8. O diagnóstico mais provável é:

A) Hidrocefalia aguda

B) Ressangramento do aneurisma

C) Isquemia tardia por vasoespasmo

D) Hiponatremia sintomática

---

18 Homem de 72 anos, com diabetes tipo 2 em uso de insulina (não usa metformina) e doença renal crônica, tem TFGe estável de 26 mL/min/1,73 m² nos últimos 12 meses. Vai fazer TC de abdome com contraste iodado intravenoso de baixa osmolalidade para estadiar uma massa renal sólida de 4 cm. Não tem insuficiência cardíaca (fração de ejeção de 58%), está euvolêmico, PA 136/78 mmHg, sem anti-inflamatórios. Não há alternativa diagnóstica sem contraste com a mesma acurácia. Quanto à prevenção de lesão renal associada ao contraste, a conduta mais adequada é:

A) Nenhuma profilaxia específica

B) Salina isotônica antes e depois

C) N-acetilcisteína oral

D) Hemodiálise após o exame

---

19 Homem de 61 anos, diabético tipo 2 há 15 anos (HbA1c 8,1%), em uso de metformina e gliclazida, procura o pronto-socorro por febre de 38,6 °C, calafrios e vermelhidão na perna esquerda há 2 dias, que começou na face anterior da tíbia e se estende até a metade da coxa. Tem maceração e fissuras entre o quarto e o quinto dedos do mesmo pé. Ao exame, FC 104 bpm, PA 128 × 76 mmHg, placa eritematosa quente e dolorosa de bordas mal definidas, sem bolhas, sem necrose, sem flutuação, sem secreção purulenta e sem crepitação; dor proporcional ao achado. Pulsos pediosos palpáveis, monofilamento sensível, sem úlcera nos pés. Leucócitos 15.800/mm³, creatinina 1,0 mg/dL. Ultrassonografia de partes moles: edema subcutâneo difuso, sem coleção. Nunca foi internado e não usou antibiótico no último ano. A conduta antimicrobiana mais adequada é:

A) Cefazolina intravenosa

B) Sulfametoxazol-trimetoprima oral

C) Vancomicina com piperacilina-tazobactam

D) Ciprofloxacino com clindamicina

---

20 Mulher de 48 anos tem diagnóstico recente de síndrome de Sjögren primária: secura ocular e oral há 2 anos, teste de Schirmer de 3 mm em 5 minutos, anti-Ro positivo e biópsia de glândula salivar menor com escore de focos de 2. Queixa-se de boca seca que atrapalha a fala e de cansaço. Nega artralgia, artrite, púrpura, aumento de parótidas, adenomegalia, dispneia ou parestesias. Exame físico normal, exceto mucosa oral seca. Hemograma, VHS, creatinina, urina tipo 1, C3, C4 e eletroforese de proteínas normais; crioglobulinas negativas. Função pulmonar normal. A conduta mais adequada é:

A) Hidroxicloroquina 400 mg/dia

B) Rituximabe em duas doses

C) Pilocarpina e lubrificantes

D) Prednisona 20 mg/dia

---

21 Mulher de 38 anos, com ganho de 14 kg em 18 meses, estrias violáceas largas no abdome, equimoses fáceis, fraqueza para subir escadas, hipertensão e diabetes recentes. Cortisol salivar ao final da noite elevado em duas amostras; cortisol livre urinário três vezes o limite superior; ACTH plasmático de 62 pg/mL (10 a 60) em duas dosagens. Potássio 3,9 mEq/L. Supressão com 8 mg de dexametasona: queda de 72% do cortisol; teste com desmopressina com elevação de 55% do ACTH. Ressonância de sela com gadolínio: lesão hipocaptante de 12 mm à direita, sem invasão do seio cavernoso. TC de tórax sem nódulos. O próximo passo mais adequado é:

A) TC de tórax, abdome e pelve

B) PET-CT com análogo de somatostatina

C) Cirurgia transesfenoidal

D) Cateterismo de seios petrosos inferiores

---

22 Mulher de 48 anos teve tromboembolismo pulmonar não provocado há 4 meses e usa rivaroxabana 20 mg uma vez ao dia, sempre no jantar, com adesão confirmada pela contagem de comprimidos. Há 6 semanas, o neurologista iniciou um medicamento para crises de dor em choque na hemiface direita desencadeadas ao escovar os dentes, com boa resposta; a dose foi aumentada há 2 semanas. Agora apresenta edema doloroso da perna esquerda, e o duplex mostra trombose femoral nova. Peso 68 kg, clearance de creatinina 92 mL/min, plaquetas 210.000/mm³, sem câncer na investigação. A conduta mais adequada para a anticoagulação é:

A) Aumentar a rivaroxabana para 30 mg/dia

B) Trocar para apixabana em dose plena

C) Implantar filtro de veia cava inferior

D) Trocar para varfarina com ponte de heparina

---

23 Homem de 19 anos teve, aos 18 anos, poliartrite migratória de grandes articulações, febre e eritema marginado, com ASLO elevada; o diagnóstico foi de febre reumática. O ecocardiograma com Doppler no surto e o repetido 6 meses depois foram normais, sem regurgitação patológica, e nunca houve sopro. Faz penicilina benzatina 1.200.000 UI a cada 21 dias desde então, sem novos surtos. Pergunta até quando deve manter a profilaxia. Pelas diretrizes vigentes, a profilaxia secundária deve ser mantida:

A) Até os 23 anos

B) Até os 25 anos

C) Até os 21 anos

D) Até os 28 anos

---

24 Mulher de 26 anos, com lúpus eritematoso sistêmico e nefrite classe IV em indução com micofenolato e prednisona 40 mg/dia há 5 semanas, procura o pronto-socorro por dispneia progressiva há 2 dias e tosse seca. Nega hemoptise. Temperatura 37,6 °C, FR 28 irpm, SpO2 89% em ar ambiente, PA 132 × 84 mmHg, sem edema e sem turgência jugular. Hemoglobina 7,4 g/dL (era 10,1 g/dL há 4 dias), sem sinais de hemólise, sem sangramento digestivo; plaquetas 168.000/mm³, coagulograma normal. TC de tórax: vidro fosco difuso bilateral, poupando a periferia, sem derrame. DLCO de 128% do previsto (há 2 meses, 74%). Beta-D-glucana negativa. O diagnóstico mais provável é:

A) Pneumonite lúpica aguda

B) Pneumonia por Pneumocystis

C) Hemorragia alveolar difusa

D) Edema pulmonar por sobrecarga

---

25 Homem de 74 anos começou com tremor de repouso na mão esquerda há 9 anos, depois lentidão e rigidez à esquerda, com resposta excelente à levodopa, hoje 200 mg 4 vezes ao dia, sem mudança de dose há 2 anos. Há 1 ano a esposa nota esquecimentos, lentidão para planejar tarefas e períodos de confusão que alternam com dias de lucidez. Há 6 meses vê pessoas desconhecidas na sala, sem medo. Há anos se debate e grita durante o sono. MoCA 17. Sem febre, sem infecção identificada, sódio e glicemia normais. RM de crânio com atrofia leve difusa, sem dilatação ventricular desproporcional. O diagnóstico mais provável é:

A) Demência da doença de Parkinson

B) Demência com corpos de Lewy

C) Doença de Alzheimer

D) Hidrocefalia de pressão normal

---

26 Mulher de 26 anos, com lúpus há 3 anos, apresenta edema de membros inferiores há 1 mês. PA 150 x 94 mmHg. Creatinina subiu de 1,1 para 1,6 mg/dL em 6 semanas; proteinúria 3,2 g/24h; hematúria dismórfica com cilindros hemáticos. C3 e C4 baixos, anti-DNA nativo 1:640. Biópsia renal: proliferação endocapilar em 70% dos glomérulos, com depósitos subendoteliais à microscopia eletrônica, crescentes celulares em 10% e índice de cronicidade de 1 de 12. Sem gestação e sem infecção ativa. A classe histológica e a indução mais adequada são, respectivamente:

A) Classe IV / micofenolato e glicocorticoide

B) Classe V / tacrolimo isolado

C) Classe III / glicocorticoide isolado

D) Classe IV / bloqueio do SRAA isolado

---

27 Mulher de 29 anos, com asma grave, foi intubada há 1 hora por exaustão. Recebe salbutamol, ipratrópio, metilprednisolona e sulfato de magnésio. Ventilação controlada a volume: volume corrente 450 mL (7 mL/kg de peso predito), frequência 26 irpm, fluxo inspiratório 60 L/min, PEEP 5 cmH2O, FiO2 0,4. Pressão de pico 52 cmH2O, pressão de platô 33 cmH2O; na pausa expiratória, PEEP total de 17 cmH2O. A curva de fluxo mostra que o fluxo expiratório não chega a zero antes do ciclo seguinte. PA 92 × 58 mmHg, FC 124 bpm, SpO2 95%. Gasometria: pH 7,16, PaCO2 78 mmHg, PaO2 96 mmHg, bicarbonato 27 mEq/L. Murmúrio diminuído e simétrico, traqueia centrada. O ajuste mais adequado do ventilador é:

A) Reduzir a frequência respiratória

B) Aumentar a frequência respiratória

C) Aumentar o volume corrente

D) Reduzir o fluxo inspiratório

---

28 Homem de 66 anos, transferido há 10 dias de um hospital que comunicou surto de Klebsiella pneumoniae produtora de NDM no mesmo setor em que ele esteve internado, apresenta febre e hipotensão no 3º dia de cateter venoso central. Duas hemoculturas crescem Klebsiella pneumoniae resistente a meropenem, cefepima e piperacilina-tazobactam. No laboratório, o teste fenotípico mostra inibição pelo ácido fenilborônico presente e sinergia com EDTA ausente; o teste imunocromatográfico é reagente para KPC e não reagente para NDM, OXA-48, VIM e IMP. Sensível à ceftazidima-avibactam e ao meropenem-vaborbactam; resistente ao aztreonam. Creatinina 1,1 mg/dL. O cateter já foi retirado. A terapia mais adequada é:

A) Polimixina B com amicacina

B) Polimixina B com meropenem

C) Ceftazidima-avibactam isolada

D) Aztreonam com ceftazidima-avibactam

---

29 Homem de 46 anos, assintomático, teve hipercalcemia detectada em exame de rotina. Cálcio total 10,9 mg/dL (8,5 a 10,2), albumina 4,3 g/dL, PTH 104 pg/mL (15 a 65), fósforo 2,6 mg/dL, 25-hidroxivitamina D 38 ng/mL, creatinina 0,9 mg/dL (TFG estimada 98 mL/min/1,73 m²), calciúria de 24 horas 210 mg. Ultrassonografia renal sem cálculos ou nefrocalcinose. Densitometria: T-escore de -1,9 na coluna lombar, -1,6 no colo do fêmur e -1,7 no terço distal do rádio; avaliação de fratura vertebral sem fraturas. Não usa lítio nem tiazídico. Deseja evitar cirurgia se possível. A conduta mais adequada é:

A) Alendronato e seguimento

B) Paratireoidectomia

C) Cinacalcete e seguimento

D) Seguimento anual com cálcio e densitometria

---

30 Mulher de 19 anos, previamente hígida, apresenta icterícia progressiva há 10 dias; 2 semanas antes usou amoxicilina com clavulanato por 7 dias para sinusite. Está sonolenta, com flapping, afebril, PA 108/66 mmHg. Exames: hemoglobina 8,1 g/dL, reticulócitos 9%, Coombs direto negativo, LDH 980 U/L, AST 410 U/L, ALT 160 U/L, bilirrubina total 28 mg/dL (indireta 9), fosfatase alcalina 18 U/L (40 a 130), INR 3,4, creatinina 1,9 mg/dL. Ceruloplasmina 24 mg/dL (20 a 60), FAN 1:80 padrão pontilhado fino, IgG 1.500 mg/dL, sorologias para hepatites A, B, C e E negativas. O plantonista não viu anéis corneanos à lanterna. O diagnóstico mais provável é:

A) Hepatite herpética disseminada

B) Hepatite autoimune fulminante

C) Hepatite por amoxicilina-clavulanato

D) Doença de Wilson

---

31 Homem de 34 anos está internado há 10 dias por meningite tuberculosa em tratamento com esquema básico e dexametasona. O sódio caiu de 138 para 124 mEq/L em 4 dias, com diurese de 4,2 litros por dia e balanço hídrico negativo. PA 112/70 mmHg deitado e 92/58 mmHg sentado, FC 112 bpm, mucosas secas. No mesmo período, o hematócrito subiu de 38% para 44% e a ureia de 30 para 52 mg/dL. Sódio urinário 168 mEq/L, osmolalidade urinária 520 mOsm/kg, ácido úrico sérico 2,1 mg/dL, TSH e cortisol normais. A conduta mais adequada para o sódio é:

A) Salina e fludrocortisona

B) Restrição hídrica a 800 mL/dia

C) Tolvaptana oral

D) Ureia oral

---

32 Homem de 61 anos com adenocarcinoma de pulmão estádio IV teve trombose venosa profunda da veia poplítea esquerda há 10 dias e usa enoxaparina 1 mg/kg de 12/12 horas. Há 4 dias tem dispneia progressiva e hoje está sonolento. PA 84 × 62 mmHg, FC 124 bpm, FR 28 irpm, SpO2 93% em ar ambiente; jugulares distendidas, pulmões limpos e bulhas abafadas. A pressão sistólica cai 18 mmHg na inspiração. ECG: taquicardia sinusal com baixa voltagem e alternância do QRS. D-dímero 4.800 ng/mL. Ecocardiograma à beira do leito: derrame pericárdico circunferencial de 2,4 cm, ventrículo direito de dimensões reduzidas e veia cava inferior de 2,3 cm sem variação respiratória. A conduta mais adequada neste momento é:

A) Furosemida intravenosa

B) Pericardiocentese de urgência

C) Trombólise com alteplase

D) Intubação e noradrenalina

---

33 Mulher de 41 anos, no décimo dia de indução para leucemia mieloide aguda, precisa de um cateter venoso central não tunelizado em veia jugular interna para nutrição e antibióticos, porque o cateter anterior foi retirado por trombose. Sem sangramento cutâneo ou mucoso, afebril, PA 118/72 mmHg. Plaquetas 24.000/mm³, hemoglobina 8,4 g/dL, INR 1,2, TTPa normal, fibrinogênio 340 mg/dL. Um intensivista experiente fará a punção guiada por ultrassom. O residente propõe transfundir plaquetas até 50.000/mm³ antes do procedimento. A conduta mais adequada é:

A) Inserir guiado por ultrassom sem transfundir

B) Transfundir uma dose de plaquetas antes

C) Transfundir até plaquetas acima de 50.000

D) Adiar até recuperação espontânea das plaquetas

---

34 Homem de 22 anos, estudante de Medicina, teve crise tônico-clônica generalizada às 7 horas da manhã, após um plantão de 30 horas sem dormir e duas latas de cerveja na noite anterior. Nunca teve crise desse tipo. Perguntado, conta que há cerca de 1 ano tem abalos bruscos nos braços pela manhã, que já o fizeram derrubar a xícara do café, sempre nos dias em que dorme pouco. Exame neurológico normal. Glicemia, sódio, cálcio e magnésio normais; toxicológico negativo. RM de crânio normal. EEG: complexos de poliespícula-onda generalizados a 4 a 6 Hz, aumentados pela fotoestimulação. A classificação do evento e a conduta quanto à droga anticrise são, respectivamente:

A) Crise provocada / sem anticrise

B) Epilepsia / iniciar anticrise

C) Crise provocada / anticrise por 6 meses

D) Epilepsia / repetir EEG antes de tratar

---

35 No adulto com febre diária acima de 39 °C, exantema evanescente cor de salmão que aparece com a febre, artralgias, odinofagia e ferritina de 9.800 ng/mL, sem infecção ou neoplasia identificadas, o achado laboratorial de maior especificidade para doença de Still do adulto é:

A) Ferritina glicosilada abaixo de 20%

B) Ferritina acima de cinco vezes o normal

C) Leucocitose neutrofílica acima de 15.000

D) Fator reumatoide e FAN negativos

---

36 Homem de 71 anos está internado com endocardite de valva mitral nativa. As hemoculturas cresceram Enterococcus faecalis sensível à ampicilina, com resistência de alto nível à gentamicina. O ecocardiograma transesofágico mostra vegetação móvel de 14 mm no folheto anterior, insuficiência mitral moderada, sem abscesso. No 4º dia de antibiótico, ainda febril, apresenta afasia de expressão e paresia discreta da mão direita, com NIHSS 3, plenamente consciente. TC de crânio: hipodensidade cortical frontal esquerda pequena, sem transformação hemorrágica; angiotomografia sem aneurisma micótico. Função renal normal, sem insuficiência cardíaca. A equipe cirúrgica considera o risco operatório aceitável. Esquema antimicrobiano e momento da cirurgia valvar, respectivamente:

A) Vancomicina e gentamicina / sem adiar

B) Ampicilina e ceftriaxona / após 4 semanas

C) Vancomicina e gentamicina / após 4 semanas

D) Ampicilina e ceftriaxona / sem adiar

---

37 Mulher de 44 anos, professora, não tabagista, sem animais em casa, refere há 7 meses tosse seca, dispneia aos esforços moderados, febre baixa e mal-estar que aparecem à noite e pela manhã. Comprou um umidificador ultrassônico para o quarto há 8 meses, que limpa a cada 15 dias. Os sintomas melhoraram durante 10 dias de viagem ao litoral e pioraram dois dias após voltar. Ausculta com estertores finos esparsos e grasnidos. SpO2 94% em repouso, 91% ao caminhar. Espirometria: CVF 76% do previsto, VEF1/CVF 0,84; DLCO 66%. TC de alta resolução: nódulos centrolobulares em vidro fosco difusos e mosaico com aprisionamento expiratório, sem reticulado, sem bronquiectasias de tração e sem faveolamento. A conduta inicial mais adequada é:

A) Prednisona 0,5 mg/kg por 3 meses

B) Criobiópsia transbrônquica

C) Micofenolato associado a prednisona

D) Retirar o umidificador e reavaliar

---

38 Mulher de 57 anos com dois episódios de cólica renal por cálculo de oxalato de cálcio nos últimos 3 anos. Há 4 meses toma uma cápsula manipulada de 10 mg ao dia, prescrita pela dermatologista para unhas quebradiças e queda de cabelo. Assintomática no momento, sem emagrecimento, sem tosse, sem dor óssea. Cálcio total 11,3 mg/dL (8,5 a 10,2), albumina 4,1 g/dL, fósforo 2,2 mg/dL (2,5 a 4,5), PTH 9 pg/mL (15 a 65, imunoensaio quimioluminescente), 25-hidroxivitamina D 34 ng/mL, PTHrP indetectável, eletroforese de proteínas normal, creatinina 0,8 mg/dL, calciúria de 24 horas 340 mg. Radiografia de tórax normal. O próximo exame mais adequado é:

A) PTH após suspender o suplemento

B) Cintilografia óssea de corpo inteiro

C) TC de tórax, abdome e pelve

D) 1,25-di-hidroxivitamina D sérica

---

39 Mulher de 66 anos, com doença renal crônica estágio 4 por nefropatia diabética (TFGe de 22 mL/min/1,73 m²), sem diálise, comparece à consulta trimestral. Sai pouco de casa e usa roupas que cobrem quase todo o corpo. PTH de 190 pg/mL há 6 meses e de 260 pg/mL agora (referência 15 a 65), cálcio 9,0 mg/dL, fósforo 4,6 mg/dL, fosfatase alcalina 140 U/L (até 120), 25-hidroxivitamina D de 13 ng/mL, bicarbonato 23 mEq/L. Já segue orientação de dieta com restrição de fósforo. O residente sugere iniciar a forma ativa da vitamina D, porque o rim doente não faz a hidroxilação. A conduta mais adequada para o hiperparatireoidismo neste momento é:

A) Paricalcitol oral

B) Calcitriol oral

C) Cinacalcete oral

D) Colecalciferol oral

---

40 Mulher de 33 anos teve febre reumática aos 9 anos e abandonou a profilaxia na adolescência. Há 8 meses tem dispneia aos médios esforços e dois episódios de palpitação. Exame: PA 106 × 70 mmHg, FC 92 bpm, ritmo regular, ictus no 5º espaço intercostal na linha hemiclavicular, não desviado, e impulsão paraesternal esquerda. Ausculta: B1 hiperfonética, estalido de abertura logo após B2, ruflar diastólico apical com reforço pré-sistólico e sopro holossistólico apical 3+/6 irradiado para a axila; sem terceira bulha. Componente pulmonar de B2 aumentado. ECG: ritmo sinusal, onda P bífida de 140 ms em DII e eixo do QRS em +100 graus. A lesão predominante é:

A) Lesões mitrais equilibradas

B) Estenose aórtica associada

C) Insuficiência mitral predominante

D) Estenose mitral predominante

---

41 Mulher de 58 anos, com cirrose alcoólica e etilismo mantido até a internação, chega com hematêmese e melena. Recebeu terlipressina, ceftriaxona e, em 8 horas, ligadura elástica de varizes esofágicas com hemostasia. Está sonolenta, desorientada no tempo e com flapping (encefalopatia grau 2), com ascite volumosa e tensa. PA 104/62 mmHg, FC 98 bpm. Exames: bilirrubina 6,2 mg/dL, albumina 2,4 g/dL, INR 2,6, creatinina 1,3 mg/dL, sódio 129 mEq/L. Ecocardiograma com função ventricular normal e pressão sistólica pulmonar estimada em 30 mmHg. O plantonista lembra que o TIPS preemptivo reduz mortalidade no Child C. A conduta mais adequada para a hipertensão portal neste momento é:

A) Derivação portossistêmica cirúrgica

B) Terlipressina por 5 dias e ligaduras seriadas

C) TIPS preemptivo com prótese recoberta

D) Obliteração retrógrada transvenosa por balão

---

42 Homem de 68 anos foi submetido a revascularização miocárdica com circulação extracorpórea e recebe enoxaparina profilática desde o primeiro dia pós-operatório. Plaquetas: 210.000/mm³ antes da cirurgia, 95.000/mm³ no segundo dia, 180.000/mm³ no quarto dia e 62.000/mm³ no sétimo dia. Sem sangramento, sem sinais de trombose ao exame e sem infecção identificada; não recebeu outros fármacos novos. Clearance de creatinina de 78 mL/min, função hepática normal. O ensaio anti-PF4 foi colhido e o resultado sai em 48 horas. A conduta mais adequada agora é:

A) Manter a enoxaparina e aguardar o anti-PF4

B) Fondaparinux em dose terapêutica

C) Varfarina com transfusão de plaquetas

D) Suspender a heparina sem anticoagular

---

43 Mulher de 38 anos, previamente hígida, recebeu tamponamento nasal anterior com gaze há 4 dias por epistaxe, com orientação de retirada em 48 horas, que não ocorreu. Há 1 dia tem febre de 39,8 °C, vômitos, diarreia aquosa e mialgia intensa. Ao exame, PA 78 × 40 mmHg após 2 litros de cristaloide, FC 128 bpm, eritema difuso tipo queimadura solar em tronco e membros, hiperemia conjuntival e da mucosa oral. Creatinina 2,6 mg/dL, CK 4.200 U/L, plaquetas 82.000/mm³, bilirrubina total 2,4 mg/dL. Duas hemoculturas sem crescimento em 48 horas. O tampão foi retirado e o Gram da secreção mostra cocos Gram-positivos em cachos; a cultura identifica Staphylococcus aureus sensível à oxacilina e à clindamicina, com teste D negativo. Já está em noradrenalina. Além do suporte, o esquema antimicrobiano mais adequado é:

A) Oxacilina isolada

B) Oxacilina com clindamicina

C) Vancomicina com meropenem

D) Penicilina cristalina com clindamicina

---

44 Mulher de 81 anos, com câncer de pâncreas metastático, está em cuidados de fim de vida no domicílio, acamada, dormindo a maior parte do dia e sem ingerir líquidos há 3 dias. A pedido da filha, que teme que a mãe 'morra de sede', a equipe iniciou há 2 dias hipodermóclise com 1.000 mL/dia de soro fisiológico. Hoje a filha está angustiada com um ruído borbulhante na garganta da mãe a cada respiração. A paciente está sonolenta, sem desconforto respiratório aparente, FR 22 irpm, com mucosa oral seca e crostas nos lábios, edema de membros inferiores 2+ e de mãos, e o ruído some parcialmente ao lateralizá-la. Usa morfina subcutânea em infusão contínua, com dor controlada. A conduta mais adequada é:

A) Aspiração da orofaringe de 2/2 horas

B) Aumentar a hipodermóclise para 1.500 mL

C) Furosemida e manter a hipodermóclise

D) Suspender o soro e fazer cuidado oral

---

45 Homem de 27 anos teve uretrite tratada com ceftriaxona e azitromicina há 5 semanas. Há 2 semanas tem dor e edema no joelho esquerdo e, há 4 dias, baixa visual no olho direito. Refere aftas orais dolorosas que voltam várias vezes por ano há 2 anos e, há 3 meses, uma úlcera escrotal dolorosa que deixou cicatriz. Ao exame, lesões papulopustulosas estéreis no tronco, artrite do joelho esquerdo, sem entesite, sem dactilite, sem lesões palmoplantares. Oftalmologia: uveíte posterior com vasculite retiniana oclusiva, sem conjuntivite. HLA-B27 negativo. Líquido sinovial inflamatório, sem cristais, cultura negativa. O diagnóstico mais provável é:

A) Artrite reativa

B) Sarcoidose

C) Espondiloartrite da doença intestinal

D) Doença de Behçet

---

46 Mulher de 19 anos é internada por vômitos, hipotensão (PA 82 × 50 mmHg) e escurecimento da pele e das gengivas nos últimos meses. Sódio 126 mEq/L, potássio 6,1 mEq/L, glicemia 64 mg/dL, cortisol às 8 horas 1,9 µg/dL e ACTH 840 pg/mL. Anticorpo anti-21-hidroxilase positivo. Tem hipotireoidismo autoimune desde os 16 anos. Teve tetania aos 9 anos e usa calcitriol e carbonato de cálcio desde então. Refere candidíase oral e ungueal de repetição desde os 4 anos. Ao exame, hipoplasia do esmalte dentário e distrofia ungueal. A alteração de base mais provável é:

A) Mutação no gene AIRE

B) Mutação no gene FOXP3

C) Haplótipo HLA-DR3 e DR4

D) Mutação no gene MEN1

---

47 Mulher de 66 anos tem miastenia gravis generalizada com anticorpo antirreceptor de acetilcolina positivo, estável há 2 anos com piridostigmina 60 mg 4 vezes ao dia e prednisona 10 mg/dia, sem mudança de dose. Há 1 mês tratou cistite com nitrofurantoína, sem intercorrências. Há 10 dias o oftalmologista prescreveu um colírio para glaucoma de ângulo aberto, e desde então a frequência cardíaca, antes de 78 bpm, caiu para 54 bpm. Há 5 dias tem ptose bilateral, diplopia, voz anasalada e cansaço para mastigar. Pupilas de 4 mm, sem sialorreia, cólicas, diarreia ou fasciculações. CVF 2,1 L (2,4 L há 6 meses). TSH normal. TC de tórax de 1 ano atrás sem massa mediastinal. A causa mais provável da piora é:

A) Crise colinérgica pela piridostigmina

B) Progressão por timoma

C) Miopatia pelo corticoide

D) Efeito do betabloqueador tópico

---

48 Homem de 79 anos, hipertenso há 25 anos com pressão bem controlada por losartana, tem dispneia progressiva aos esforços e edema de membros inferiores há 1 ano. Foi operado de síndrome do túnel do carpo nos dois punhos aos 68 e aos 70 anos, teve ruptura espontânea do tendão do bíceps direito e tem estenose de canal lombar. PA 112 × 70 mmHg, FC 64 bpm, jugulares túrgidas a 45 graus, hepatomegalia discreta. Ecocardiograma: septo e parede posterior de 17 mm, FE de 52%, padrão restritivo de enchimento e strain longitudinal com preservação apical. Imunofixação sérica e urinária negativas e relação de cadeias leves livres normal. O achado eletrocardiográfico que mais reforça a hipótese etiológica é:

A) Bloqueio de ramo direito com bloqueio divisional anterossuperior

B) Baixa voltagem dos QRS nas derivações periféricas

C) Ondas T gigantes negativas de V2 a V5

D) Critérios de Sokolow-Lyon com padrão de strain

---

49 Mulher de 24 anos, estudante de nutrição, IMC de 19 kg/m², é encaminhada pela psiquiatra com suspeita de bulimia por cãibras, fadiga e episódios de parestesias em mãos; a dentista notou desgaste do esmalte. Ela nega vômitos, laxantes e diuréticos. PA 104/66 mmHg, sem edema. Potássio 2,8 mEq/L, bicarbonato 32 mEq/L, magnésio 1,2 mg/dL (1,7 a 2,4), cálcio 9,8 mg/dL, creatinina 0,7 mg/dL. Urina: cloro 92 mEq/L, potássio 64 mEq/L, relação cálcio/creatinina de 0,03 mg/mg; pesquisa urinária de diuréticos negativa em duas amostras colhidas sem aviso. O diagnóstico mais provável é:

A) Síndrome de Bartter

B) Uso oculto de diurético de alça

C) Síndrome de Gitelman

D) Vômitos autoinduzidos

---

50 Homem de 63 anos, no 4º dia de pós-operatório de artroplastia de quadril, teve TEP confirmado por angiotomografia há 10 horas, com trombos nas duas artérias pulmonares principais. Na admissão estava com PA 118 × 74 mmHg, FC 112 bpm, VD/VE de 1,3 ao ecocardiograma e troponina elevada, e iniciou heparina não fracionada em infusão, com TTPa no alvo. Agora está sudoreico, confuso, com PA sistólica de 82 mmHg por 20 minutos apesar de 500 mL de cristaloide, FC 128 bpm, lactato 4,6 mmol/L, SpO2 88% com cateter de oxigênio. Não teve sangramento da ferida, hemoglobina estável, plaquetas 210.000/mm³, sem AVC prévio. Classificação de risco atual e conduta, respectivamente:

A) Alto / trombólise sistêmica

B) Intermediário-alto / manter heparina e vigiar

C) Alto / filtro de veia cava inferior

D) Intermediário-alto / trombólise em meia dose

FOLHA DE RESPOSTAS

Simulado R02

Nome: _____ Data: ___/___/_____ Início: ___h___ Fim: ___h___

1	A	B	C	D	2	A	B	C	D	3	A	B	C	D	4	A	B	C	D
5	A	B	C	D	6	A	B	C	D	7	A	B	C	D	8	A	B	C	D
9	A	B	C	D	10	A	B	C	D	11	A	B	C	D	12	A	B	C	D
13	A	B	C	D	14	A	B	C	D	15	A	B	C	D	16	A	B	C	D
17	A	B	C	D	18	A	B	C	D	19	A	B	C	D	20	A	B	C	D
21	A	B	C	D	22	A	B	C	D	23	A	B	C	D	24	A	B	C	D
25	A	B	C	D	26	A	B	C	D	27	A	B	C	D	28	A	B	C	D
29	A	B	C	D	30	A	B	C	D	31	A	B	C	D	32	A	B	C	D
33	A	B	C	D	34	A	B	C	D	35	A	B	C	D	36	A	B	C	D
37	A	B	C	D	38	A	B	C	D	39	A	B	C	D	40	A	B	C	D
41	A	B	C	D	42	A	B	C	D	43	A	B	C	D	44	A	B	C	D
45	A	B	C	D	46	A	B	C	D	47	A	B	C	D	48	A	B	C	D
49	A	B	C	D	50	A	B	C	D										